

眼科救急疾患

2026/6/3

眼科救急疾患

- 急性緑内障発作
- 網膜中心動脈閉塞症
- 眼内炎
- 穿孔性眼外傷
- 化学外傷
- 眼窩底骨折
- そのほか、、、

- 対光反射・瞳孔径

→緑内障発作、動眼神経麻痺、 Horner 徴候

- 視力評価

- (視野評価)

- 眼球運動→眼窩底骨折での下直筋陥頓など

- 既往歴、眼科治療歴、家族歴など

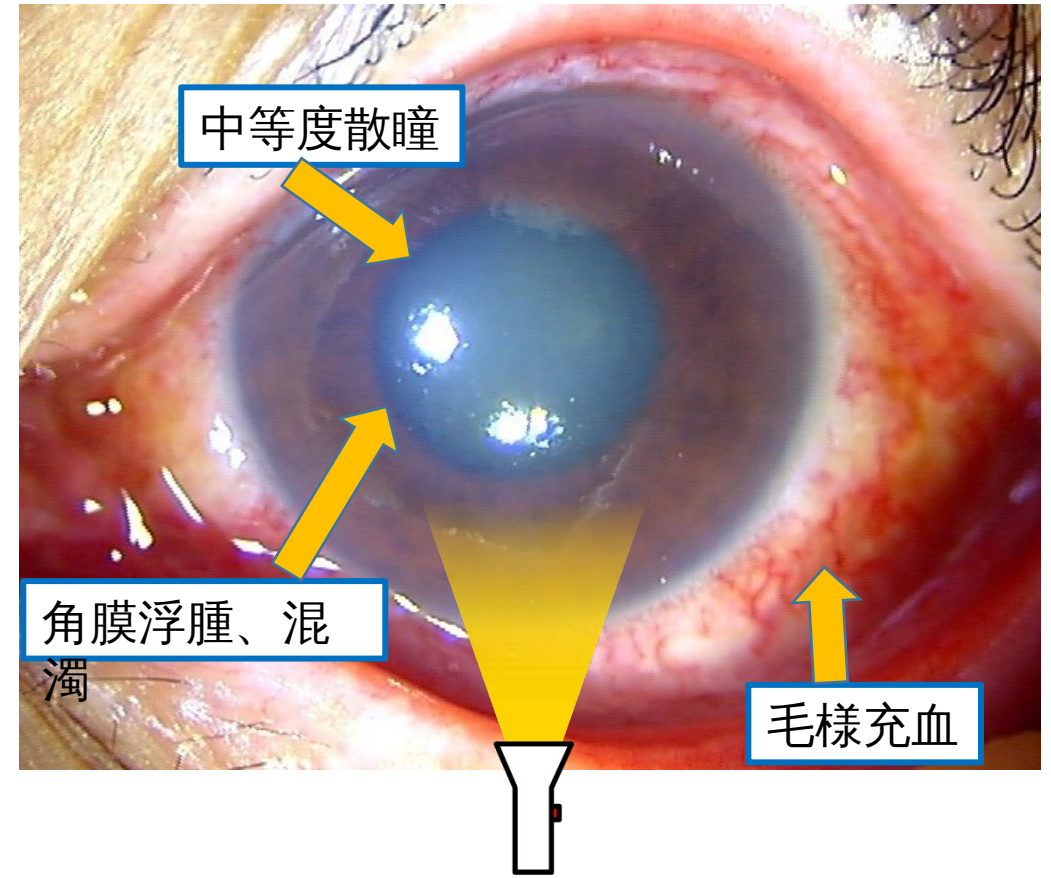
急性緑内障発作

「頭が痛くて気持ち悪い！」

- ・眼痛
- ・頭痛
- ・嘔気

「片目がぼやけて見える！」

- ・視力低下、霧視



対光反射の消失や遅延

急性緑内障発作

リスク 高

- ・ 高齢者
- ・ 遠視、浅前房・狭隅角
- ・ 家族歴

リスク 低

- ・ 白内障の手術歴
- ・ 近視

眼圧測定で高眼圧（正常値は 21mmHg 以下）

急性緑内障発作



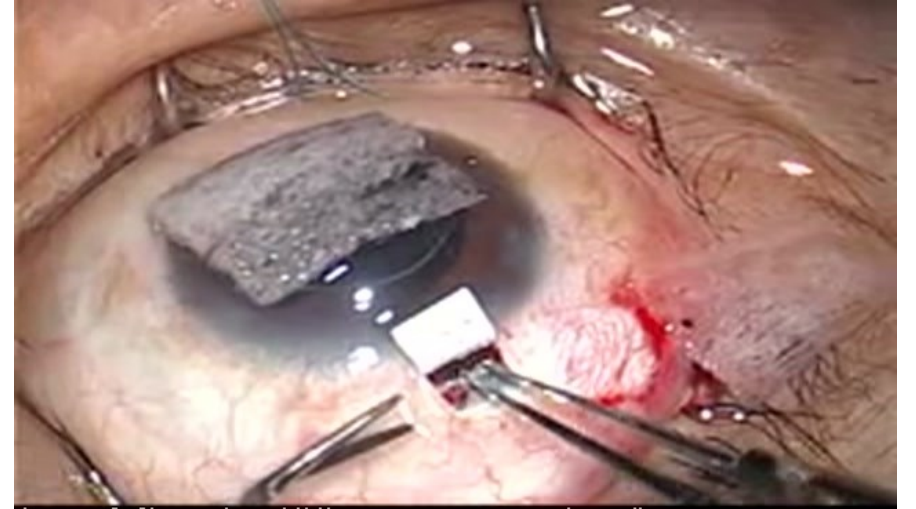
●治療

- ・ 塩酸ピロカルピン（縮瞳）の点眼
- ・ マンニトール点滴
 - ※腎機能異常は慎重投与、心不全患者でも避ける
- ・ レーザー虹彩切開術

急性緑内障発作

●手術治療

- ・ 周辺虹彩切除術
- ・ 白内障手術



網膜中心動脈閉塞症

「突然目が見えなくなった！」

- ・ 突然の視力低下
- ・ 多くは片側性
- ・ 痛みや充血なし

リス

- ク
- ・ 心房細動
 - ・ 高血圧、高脂血症など動脈硬化因子

Cherry red spot



30 ~ 60 分以内に不可逆的な変化になります

網膜中心動脈閉塞症

網膜中心動脈の閉塞
中心暗点

●治療

- ・ 眼球マッサージ
- ・ 血栓溶解薬投与 (t-PA)

化学外傷

アルカリ性 / 酸性物質による角膜傷害



★アルカリ性物質、高濃度酸や強酸は
組織浸透性が高いので注意！！

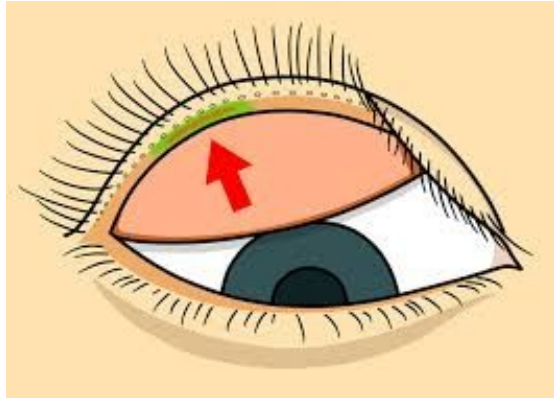
アルカリ性物質・・・石灰、トイレ洗剤、毛染液など

原因薬剤の聴取を忘れずに！

化学外傷

●治療

生理食塩水で洗浄（少なくとも 500ml 以上）



★洗浄の目安はpHが中性になるまで（7.5 前後を目標）

処方：抗生剤点眼

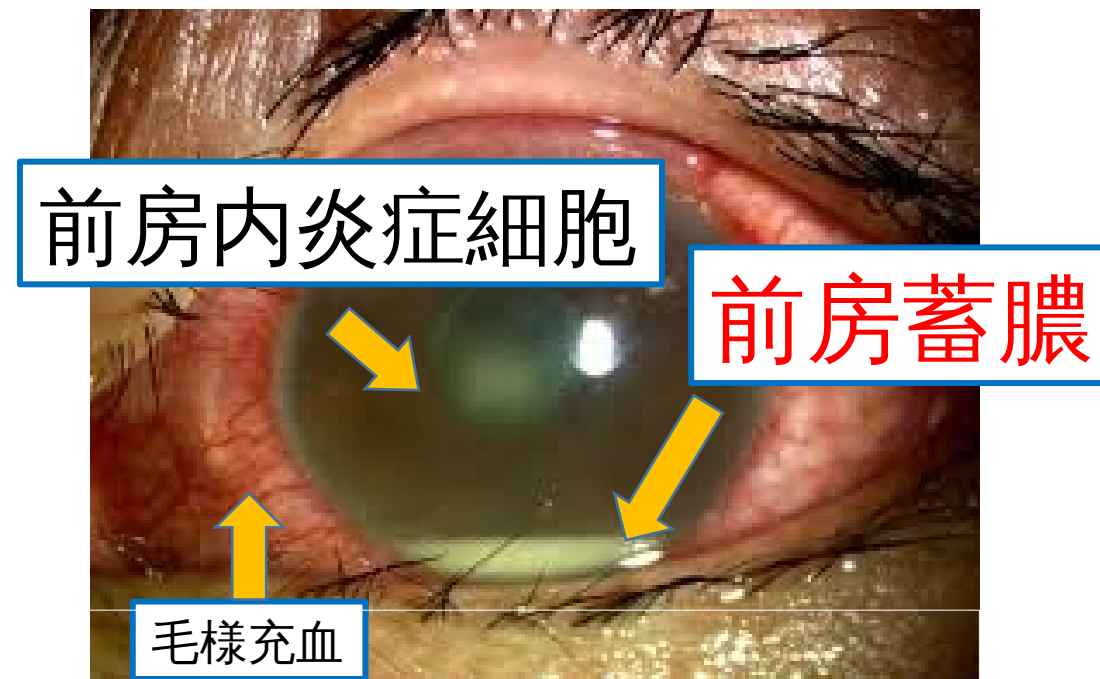
細菌性眼内炎

「1週間前に目の手術をしてから目が見えなくなってきた痛い」

- ・多くが片眼性
- ・視力低下、霧視
- ・眼痛

★病歴聴取！

- ・眼内手術後
- ・肝膿瘍、糖尿病、免疫抑制療法



眼内炎

●治療

- ・ 抗菌薬の結膜下・硝子体内注射、点眼薬
- ・ 感染源の治療→全身への抗菌薬投与
- ・ 硝子体手術
排膿、感染源の硝子体を除去

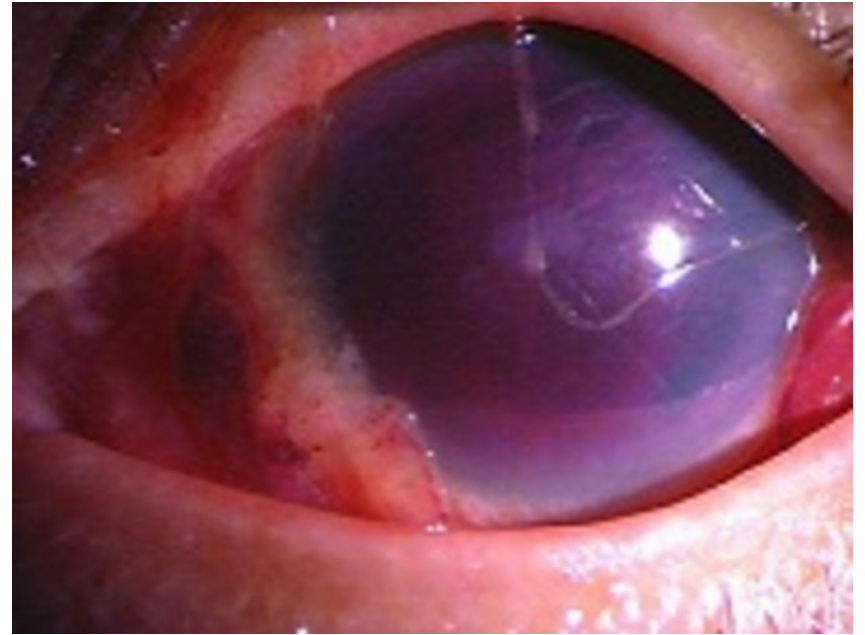
細菌性眼内炎の場合は数分単位で視力低下が進行すること

穿孔性眼外傷

鋭的、鈍的外傷による眼外膜
(角膜、結膜、強膜) への損傷

- 低眼圧、硝子体脱出
- 角膜裂傷
- 瞳孔不正円、虹彩脱出
- 前房出血

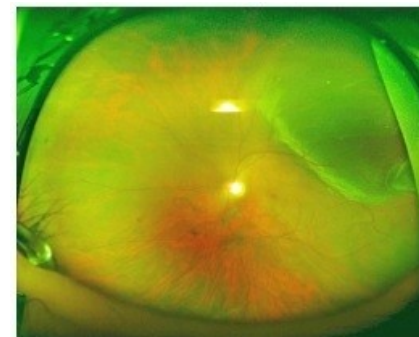
→ 頭部 CT で眼窩含め頭蓋内の異常など無いか検索



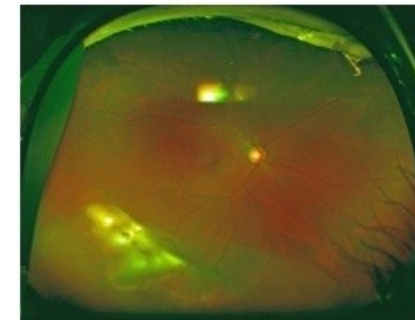
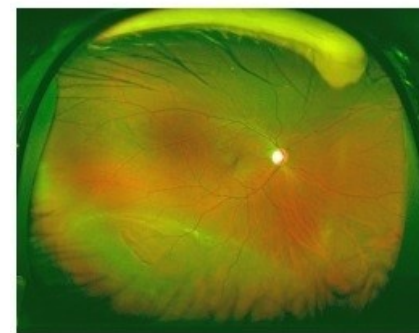
裂孔原性網膜剥離

「視界の端に黒い影が出てきた」
「飛蚊症が増えた」

→ 網膜裂孔
網膜が脆弱、薄い部分に生じる



裂孔原性網膜剥離に対する硝子体手術 (左) 術前 (右) 術後



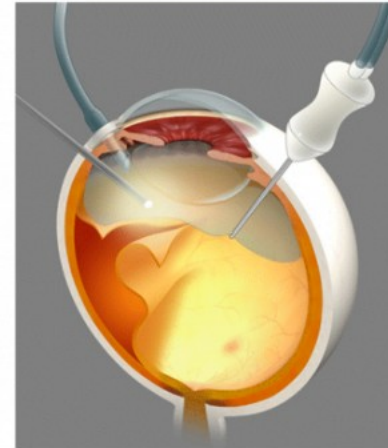
萎縮性円孔による網膜剥離に対する強膜バックリング手術 (左) 術前 (右) 術後

裂孔原性網膜剥離

治療

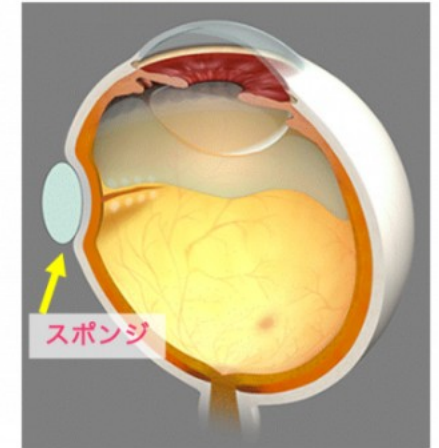
- ・硝子体手術
- ・強膜陥入術 / 輪状締結術

硝子体手術



眼の中に器具を挿入して、剥がれた網膜を直接元の位置に戻す。

強膜内陥術



眼の外側にスポンジを押し当てることで、剥がれた網膜を接着させる。

視神経炎

「突然、ぼやけ始めた、色が変」
視神経乳頭部の腫脹

- ・ 眼痛、眼球運動時痛があることも
- ・ 患側の RAPD 陽性
- ・ 眼窩 MRI T2 脂肪抑制、STIR、FLAIR で視神経が高信号
- ・ 初期治療は副腎皮質ステロイド

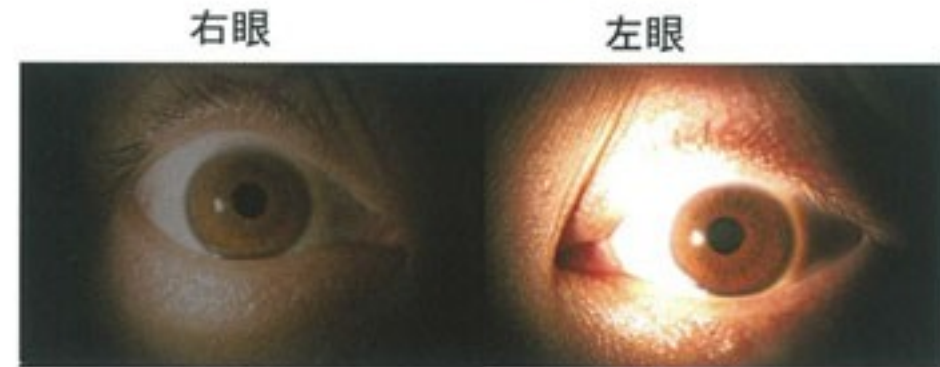


視神経炎

RAPD

健眼に光を当てると両眼縮瞳
患眼に光を当てると両眼散瞳

視神経、網膜に異常があると生じる



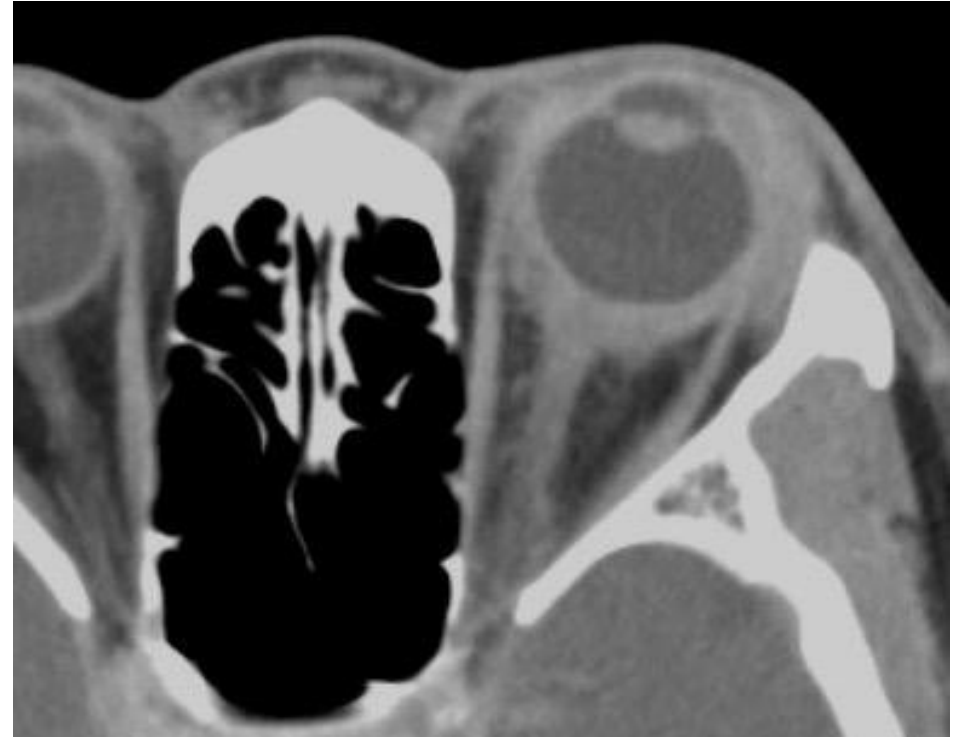
斷影嚮)



蜂窩織炎

染

突出



治療 抗生剤点滴

急性涙嚢炎

鼻涙管が詰まり、涙嚢へ細菌感染

目頭の腫脹・発赤

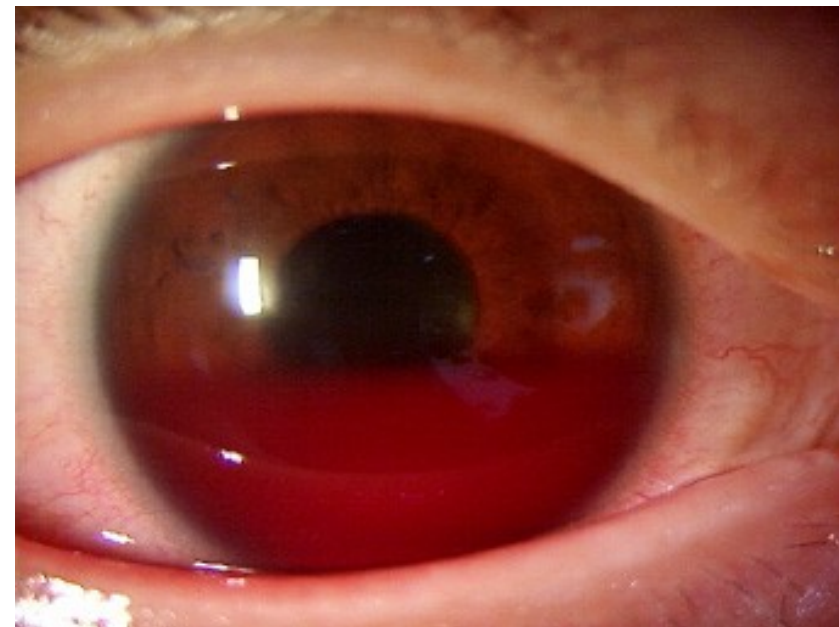
眼脂、排膿

治療 抗生剤全身投与、点眼

前房出血

鈍的外傷によって虹彩、毛様体が損傷を受けて生じる

- ・出血量が少量なら経過観察



軽傷

〈電気性眼炎〉

- ・溶接作業やスキー後 30 分～ 24 時間経ってから症状が出現
- ・眼痛、流涙、異物感など

経過観察可

処方：抗生剤点眼など

軽傷

〈帯状疱疹〉

- ・ Hutchinson 兆候あると眼合併症の可能性高い

角膜炎、結膜炎

処方：抗ウイルス薬



軽傷

〈結膜下出血〉

- ・特発性がほとんど、手術後など
- ・自然経過で消退
- ・穿孔や打撲無いか確認



〈角膜、結膜異物〉

- ・表面麻酔点眼の上、綿棒で優しく除去
 - ・角膜異物の場合、除去手技で穿孔の危険あり
- 処方：抗生剤点眼など

軽傷

〈コンタクトレンズトラブル〉

- ・コンタクトレンズの不適切使用、ケース汚染などで角膜上皮障害

※使い捨て用をつけて数週間つけたままの人も！

- ・角膜感染症の危険



最後に

- ①眼科疾患は、通常、救急処置を必要としないことが多い
- ②重症度を考える上で重要なのは「視機能障害」
 - 見えるか、見えないか？
 - 対応が遅れることで不可逆性の障害となり得るかどうか
- ③緊急性が高いのは
 - 穿孔性眼外傷をはじめとした眼外傷
 - 突然の視力低下をきたす疾患